Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Chapadão do Sul
Gabinete 2ª Vara

Procedimento Comum Cível 0800270-76.2019.8.12.0046 (Fornecimento de Medicamentos, Antecipação de Tutela / Tutela Específica e Obrigação de Fazer / Não Fazer) – Elvina Evangelista x Estado de Mato Grosso do Sul e Município de Chapadão do Sul

SENTENÇA

ELVINA EVANGELISTA, Brasileira, Solteira, Cabeleireira, RG 734854, CPF 429.989.991-15, pai Gino Evangelista, mãe Elvira Aparecida Evangelista, Nascido/Nascida 01/08/1969, Rua C, 156, Esperança, CEP 79560-000, Chapadão do Sul - MS, ajuíza ação contra ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, CNPJ 15.412.257/0001-28, com endereço à Parque dos Poderes Bloco IV, Parque dos Poderes, CEP 79900-000, Campo Grande - MS e MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO SUL, CNPJ 24.651.200/0001-72, com endereço à Avenida Seis, 706, Centro, CEP 79560-000, Chapadão do Sul - MS, e pede o fornecimento de remédio/tratamento relacionado à saúde, bem como indenização por danos morais.

Para tanto alega que não dispõe de condições financeiras para adquirir medicamentos e necessita de tratamento a ser custeado pelo Sistema Único de Saúde – SUS, pena de riscos diversos, ao passo que o medicamento não está sendo fornecido pelo sistema público de saúde.

Parecer do NAT desfavorável.

Tutela provisória indeferida.

Agravo de instrumento interposto (51).

Citados os requeridos, o Município apresentou contestação afirmando existência de medicamento similar disponibilizado pelo SUS; responsabilidade solidária dos entes; prejuízo a saúde financeira; prejuízo a saúde financeira e orçamentária do município; do crime de responsabilidade por inobservância das normas sobre despesa pública; ausência de dano moral. O Estado, alega, preliminarmente, ilegitimidade passiva do Estado; no mérito, alega, da existência de tratamento oferecido pelo SUS para diabetes, com indicação de medicamentos com efeitos idênticos; ausência de prova da imprescindibilidade dos medicamentos e da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS; ausência do dever de indenizar; impossibilidade da cominação de multa; impossibilidade de condenação do Estado ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da defensoria.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SILVIO CEZAR DO PRADO, liberado nos autos em 29/07/2019 às 18:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800270-76.2019.8.12.0046 e código 94ybBt1y.

Em manifestação após a defesa, a pretensão é ratificada.

Motivação

A hipótese comporta julgamento antecipado e, conforme entendimento majoritário dos Tribunais, preenchidos os requisitos para o julgamento antecipado da lide, o magistrado tem o poder-dever de conhecer diretamente do pedido, proferindo sentença, em atenção aos princípios que regem o processo.

A autora é portadora de Diabetes Melitus Insulino (CID E 10.6), e em decorrência desse mal necessita fazer uso de Insulina Lantus (glargina) ingerindo-o, diariamente, 25 unidades cedo e 10 unidades a noite.

A indicação mencionada acima foi feita por médico especialista (f.18-21), sendo certo que a conveniência do uso do medicamente é de competência exclusiva desse profissional, que segue os preceitos do Código de Ética inerente a sua profissão. Assim, não há porque se duvidar da lisura e da necessidade da recomendação médica, haja vista não ter sido produzido nos autos qualquer indício que pudesse enfraquecer a prova pré- constituída.

Cumpre ressaltar que o acesso à saúde foi elevado à condição de direito fundamental do homem, sendo incontroverso o dever do Poder Público, assim entendidos a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios, em disponibilizar serviços de saúde pública a todos os cidadãos. A responsabilidade é solidária.

A Constituição Federal, em seus artigos 196 e 198, assim dispõe:

> *Art. 196. A saúde é o direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.*
>
> *Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: I – descentralização, com direção única em cada esfera de governo; II – atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais; III – participação da comunidade. § 1º. O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.*

Do mesmo teor a Lei Federal 8.080/90 (Lei Orgânica da Saúde):

> *Art. 2.º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.*
>
> *Art. 4.º O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SILVIO CEZAR DO PRADO, liberado nos autos em 29/07/2019 às 18:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800270-76.2019.8.12.0046 e código 94ybBt1y.

mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS).

A matéria, portanto, recebe tratamento de direito inalienável da pessoa humana, pois a Constituição Federal consignou a obrigação de Estado propiciar ao homem o direito fundamental à saúde, consagrando o Sistema Único de Saúde – SUS como responsável pelas ações e serviços públicos de saúde, composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, e organizado de acordo com a descentralização, prestando serviço de atendimento de forma integral, ou seja, a assistência à saúde deverá seguir as diretrizes estabelecidas constitucionalmente, de forma ampla e universal, sem restrições por Autoridades Administrativas, no sentido de reduzi-lo ou dificultar o acesso a essa garantia constitucional.

A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em caso semelhante ao dos autos, assim tem concluído:

> *PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. MEDICAMENTO NÃO CREDENCIADO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). FORNECIMENTO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DO FÁRMACO. COMPROVAÇÃO. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA. (AgInt. no REsp. 1.553.112/CE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 10/03/2017).*

Frisa-se, portanto, que o direito à saúde compreende também o acesso à assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica, de modo que a todos deve ser garantido o acesso aos medicamentos necessários para promoção e tratamento de saúde.

Todavia, não se trata de direito absoluto, cabendo a parte demonstrar a efetiva necessidade do uso do medicamento/tratamento a ser fornecido pelo ente político, comprovando, ainda, que o medicamento/tratamento requerido é insubstituível por outro similar/genérico.

Nesse sentido, tratando-se o pedido do fornecimento de medicamento não incorporado pelo SUS, mesmo havendo alternativas terapêuticas disponibilizadas pela rede pública e que possuem os mesmos princípios ativos dos fármacos requeridos, necessária a presença cumulativa dos requisitos estabelecidos no julgamento do Recurso Especial nº 1657.156- RJ, TEMA 106, o STJ:

A) Comprovação, por laudo médico fundamentado, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento requerido, bem como da ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo sus para o tratamento da moléstia;

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SILVIO CEZAR DO PRADO, liberado nos autos em 29/07/2019 às 18:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800270-76.2019.8.12.0046 e código 94ybBt1y.

B) Comprovação da incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

C) Existência de registro do medicamento na ANVISA.

No caso dos autos, os Laudos produzidos pela médica da autora a f.18-21, comprovam não há outra opção para o tratamento da moléstia que a acomete senão o receitado. Justificou que a paciente utilizou por 15 anos o tratamento fornecido pelo SUS, sem obtenção de resultados positivos.

De fato, a única pessoa que detém conhecimento científico suficiente para propor o melhor para o paciente é o médico responsável pelo tratamento, assim, não há porque se duvidar do medicamento por ele indicado.

Ressalte-se que o medicamento indicado possui registro na ANVISA, conforme informado a f.43.

Frisa-se a existência de solidariedade entre os entes público, mas não se pode ignorar que há um divisão, cabendo aos municípios, estados e União, o ônus, exatamente conforme a complexidade.

Havendo meios de se comprovar, e, estando comprovado nos autos exatamente de quem é a responsabilidade, a obrigação deve ser exigida da pessoa jurídica obrigada.

Houvesse de fato interesse em resolver problemas de saúde, sequer ação seria necessária.

Destaque-se, não há que se falar em aplicação da teoria da reserva do possível, vez que o fornecimento de um ou vários medicamentos a uma pessoa, que de fato necessita, não tem o condão de lesar os cofres públicos. E por isso mesmo, perfeitamente possível que o Estado resguarde os interesses de pessoas desprovidas de satisfatória situação econômico-financeira.

Quanto à multa cominatória, deve ser aplicada, tendo em vista a efetiva necessidade do tratamento demonstrada nos autos. A jurisprudência afirma:

> *AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA CONTRA ENTE PÚBLICO POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. MATÉRIA PACIFICADA NO STJ (RESP. 1.474.665/RS, JULGADO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS). AGRAVO INTERNO DA UNIÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência dessa Corte, ao julgar o REsp. 1.474.665/RS, representativo de controvérsia, de relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, julgado sob o rito dos Recursos*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SILVIO CEZAR DO PRADO, liberado nos autos em 29/07/2019 às 18:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800270-76.2019.8.12.0046 e código 94ybBt1y.

Repetitivos, em seção de 26.4.2017, firmou orientação segundo a qual é possível a fixação de multa diária contra ente público em caso de descumprimento de determinação judicial de fornecimento de medicamentos ou tratamento de saúde. 2. Agravo Interno da União a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1489212/SE AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2014/0268416-1. Min Napoleão Nunes Maia Filho. Dj.E 27/06/2017).

No que tange ao dano moral, em que pese o inconformismo da autora, a negativa do Estado ao fornecimento do medicamento, por si só, para configurar o dano moral indenizável, até mesmo porque não há prova nos autos de que o atraso no atendimento tenha proporcionado danos à autora.

Evidente, pois, que no caso dos autos, a Autora tenha passado por aborrecimento, insatisfação, desgosto, em razão da a negativa do Estado ao fornecimento do medicamento, todavia, estes não se mostram aptos para gerar o dever de indenizar.

Destaca-se que ela não foi exposta a situação vexatória ou a qualquer constrangimento que pudesse afetar sua imagem, intimidade ou honra, assim não há como se afirmar que os fatos aqui descritos tenha causado dano moral indenizável.

Outrossim, a Autora sequer demonstrou quais teriam sido as consequências que o atraso no atendimento teriam lhe proporcionado.

Assim, não há que se falar em indenização por dano moral.

Destarte, impõe-se a procedência do pedido inicial.

Conclusão

1. Nos termos do Art. 487, I, do CPC, julgo procedente em parte a pretensão inicial e condeno os réus a fornecerem a Elvina Evangelista, o medicamento/tratamento indicado na inicial, dando-se preferência à utilização de genérico, se houver, na quantidade necessária a ser ministrada pelo paciente, durante todo o tratamento, de forma permanente e por prazo indeterminado, pena de responsabilidade criminal e multa diária que se fixa em R$ 500,00. Para tanto, observo a tese firmada em sede de repetitivo no Tema 98/STJ. Julgo improcedente o pedido de dano moral.

2. Sem custas e honorários porque há confusão entre o Estado e Defensoria. Este é órgão daquele, e quanto ao Município porque se usa indistintamente o acesso ao Judiciário, com base em responsabilidade

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SILVIO CEZAR DO PRADO, liberado nos autos em 29/07/2019 às 18:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800270-76.2019.8.12.0046 e código 94ybBt1y.

solidária, o que não pode ter reflexo em ônus de sucumbência, quando o SUS é claro ao dispor a quem compete o que.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Arquive-se.

Chapadão do Sul, 29/07/2019 15:11.

Juiz Silvio C. Prado

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SILVIO CEZAR DO PRADO, liberado nos autos em 29/07/2019 às 18:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800270-76.2019.8.12.0046 e código 94ybBt1y.